PESQUISA E DADOS
www.pesquisaedados.com

RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E REGULATÓRIA

CÂNCER DE MAMA

HER2-POSITIVO

Pipeline Global · Análise por Indicação · Paisagem Competitiva

Terapias Emergentes · Presença no Brasil

Fonte de dados: ClinicalTrials.gov — Outubro de 2026

Fonte primária: U.S. National Library of Medicine (API v2)

Data de coleta: 16 de outubro de 2026 · 725 estudos (Fases 2–4)

Classificação: Uso Interno — Confidencial

© 2026 Pesquisa e Dados. Todos os direitos reservados.

Índice

1. Sumário Executivo	3
2. Panorama Geral do Pipeline	4
3. Concentração Geográfica da Pesquisa	5
4. Análise por Indicação (subtipo × estágio)	6
5. Paisagem Terapêutica — Fármacos e Classes	8
6. Análise Competitiva — Patrocinadores	9
7. Pipeline Emergente — ADCs e Novas Moléculas	10
8. Presença no Brasil	11
9. Análise Regulatória e Ciclo de Vida	12
10. Conclusões e Recomendações Estratégicas	13

Metodologia e Escopo

Fonte: ClinicalTrials.gov (U.S. National Library of Medicine), API v2, coleta em 16/10/2026. Universo: 725 ensaios intervencionais em câncer de mama relacionados a HER2, nas Fases 2, 3 e 4, com status ativo (recrutando, ativo/não-recrutando, não iniciado ou por convite). Classificação clínica: cada estudo foi categorizado por subtipo molecular (HER2+, HR+/HER2-, TNBC) e por estágio da doença (inicial/(neo)adjuvante, metastático/avançado, metástase cerebral), a partir de processamento textual de condições, título, resumo e intervenções. Limitações: o módulo de localizações geográficas não foi preservado na coleta — a presença no Brasil e a região do patrocinador são estimativas conservadoras (ver seções 3 e 8).

Como ler este relatório: os números refletem a atividade de pesquisa (volume de estudos e capacidade de pacientes), não vendas ou participação de mercado. Um alto volume de estudos sinaliza intensidade competitiva e prioridade estratégica das empresas naquela indicação ou molécula.

1. Sumário Executivo

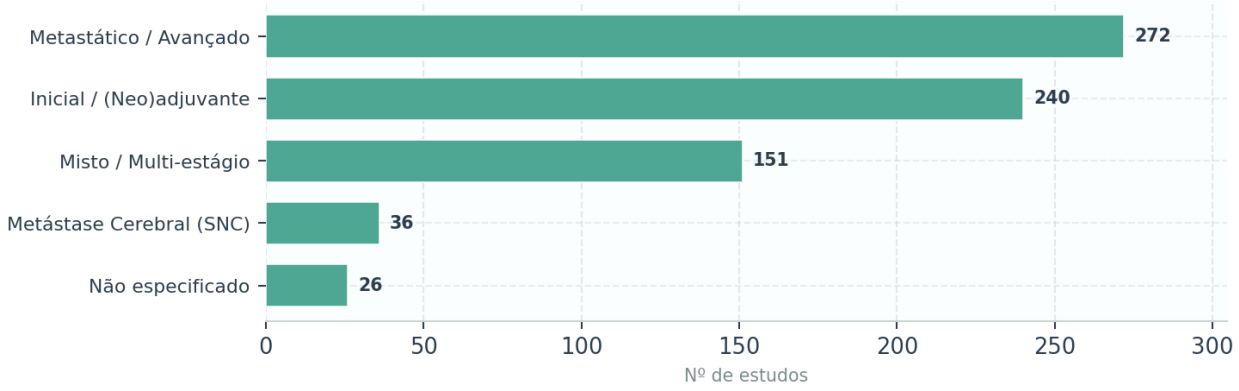
Este relatório mapeia o panorama global de ensaios clínicos em câncer de mama HER2-positivo, com base em 725 estudos ativos (Fases 2–4) e mais de 406 mil pacientes planejados. A análise segmenta o pipeline por indicação clínica, paisagem terapêutica, concentração competitiva e geográfica, com foco nas implicações estratégicas para a indústria farmacêutica e na oportunidade ainda subexplorada do mercado brasileiro.

725	362	210	406k	6
Estudos ativos Fases 2, 3 e 4	Recrutando Abertos a pacientes	Em Fase 3 Pipeline de registro	Pacientes Capacidade planejada	Com Brasil < 1% do pipeline

Principais Achados Estratégicos

- Pipeline em expansão acelerada: os novos estudos por ano cresceram de ~19 (2019) para 135 (2025) — alta superior a 7×. O semestre parcial de 2026 já soma 92 estudos, indicando que o recorde deve ser superado.
- O foco migrou para a doença metastática: a indicação Metastático/Avançado lidera com 272 estudos, seguida de perto pela doença inicial/(neo)adjuvante (240), que concentra a maior capacidade de pacientes (intenção curativa, estudos maiores).
- ADCs redefinem o padrão de cuidado: liderados por Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd), os Anticorpo-Conjugados a Drogas são a classe de inovação mais dinâmica, com uma onda de candidatos asiáticos (SHR-A1811, ARX788, RC48) desafiando o paradigma.
- A China é o epicentro da pesquisa: ao menos 262 estudos (36%) têm patrocinador chinês — mais que EUA e Europa juntos entre os classificáveis, sinalizando uma mudança no eixo global de P&D; oncológico.
- Brasil sub-representado: apenas 6 estudos com menção ao país (< 1% do pipeline), evidenciando uma oportunidade estratégica de atração de centros e investimento.

O Pipeline em um Relance — Estudos por Estágio Clínico



A doença metastática e a inicial/(neo)adjuvante respondem pela maioria do pipeline ativo (detalhamento na seção 4).

2. Panorama Geral do Pipeline

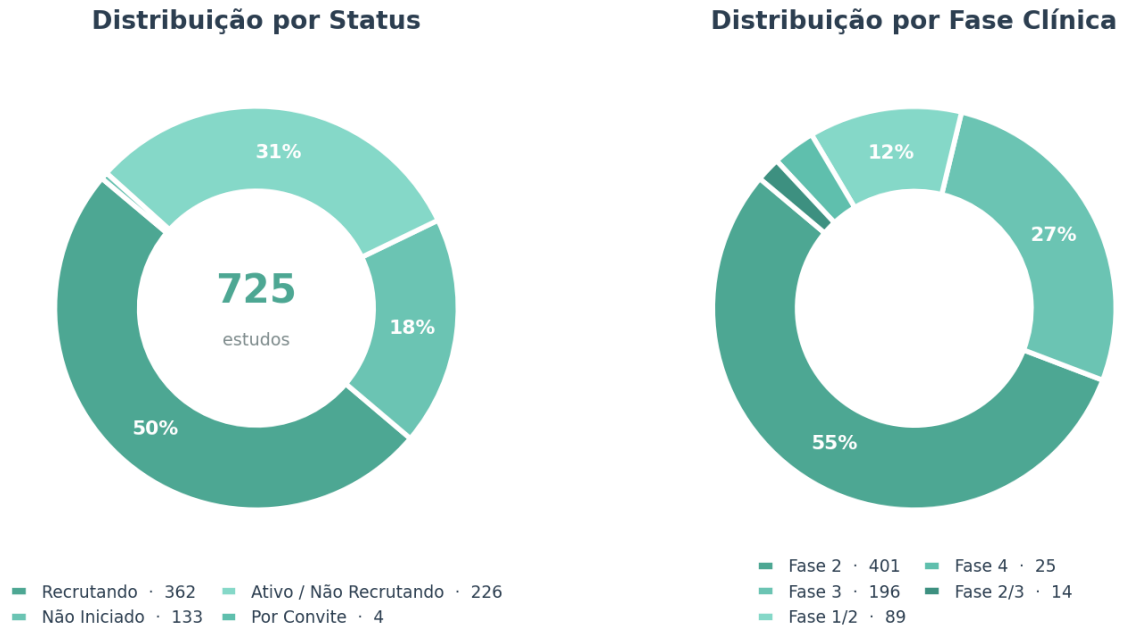


Figura 1 — Status de recrutamento (esq.) e fase clínica (dir.) dos 725 estudos. Metade está em recrutamento ativo; 30% em Fase 3 (estágio de registro).

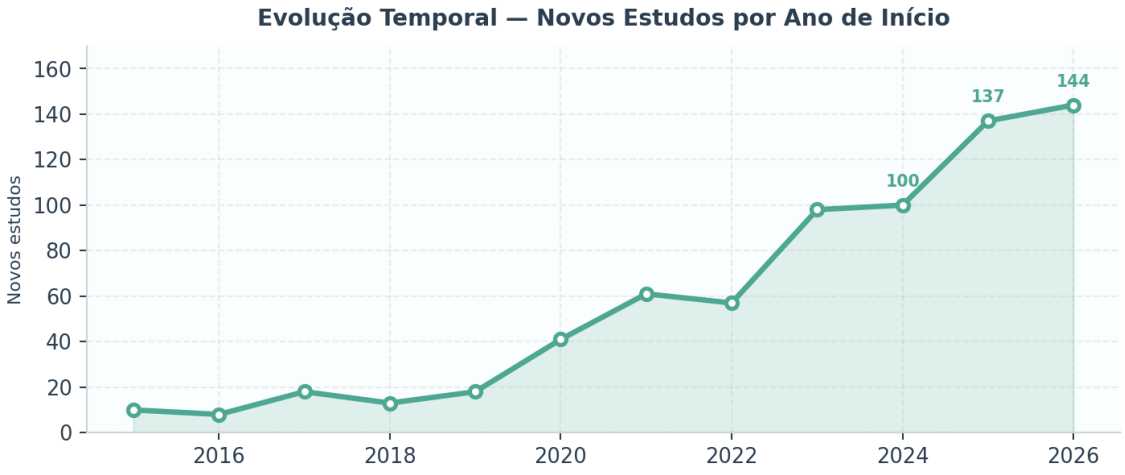


Figura 2 — Novos ensaios iniciados por ano (2015–2026). Crescimento >7× na última década.

Nota: os dados de 2026 são parciais (coleta em junho/2026). Os 92 estudos já registrados representam apenas o 1º semestre — em ritmo de superar o recorde de 135 estudos de 2025.

3. Concentração Geográfica da Pesquisa

A origem do patrocinador líder revela onde está sendo gerado o conhecimento clínico em HER2+. A classificação abaixo é uma estimativa por heurística sobre o nome do patrocinador (instituições e empresas reconhecidas); estudos não classificáveis aparecem como "Outros / N/D".

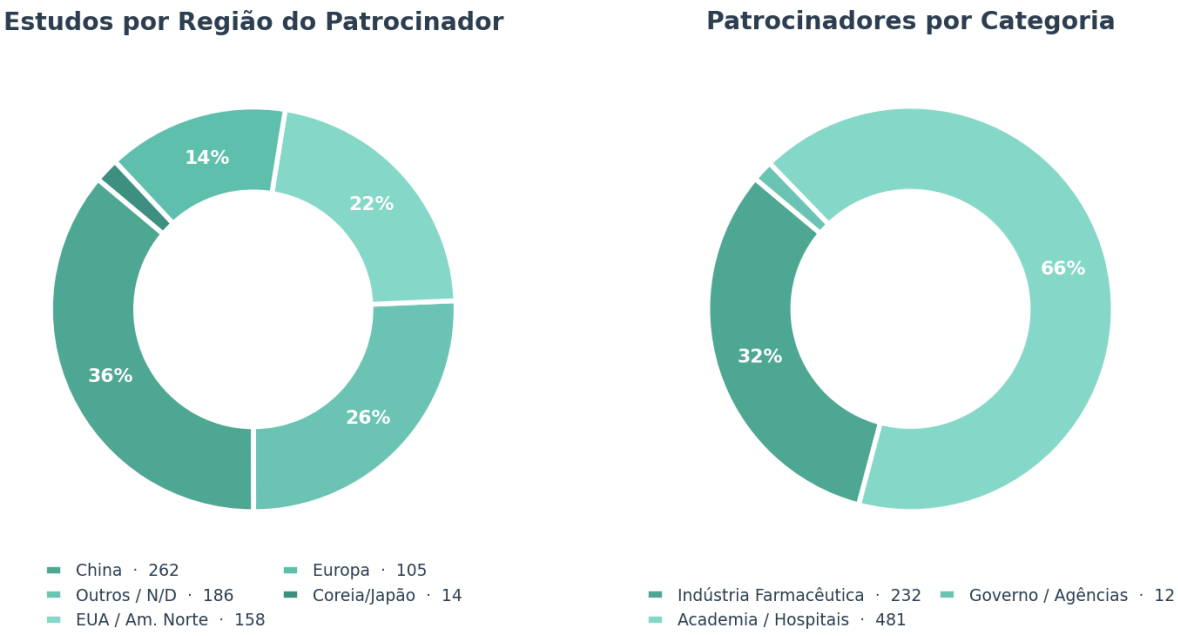


Figura 3 — Região do patrocinador líder (esq.) e categoria institucional (dir.).

O eixo da pesquisa migrou para a Ásia. Com pelo menos 262 estudos (36%), a China supera EUA e Europa individualmente — e provavelmente é subestimada, pois parte do bucket "Outros / N/D" também é chinesa (farmacêuticas e hospitais regionais). Instituições como Fudan University, Henan Cancer Hospital e Sun Yat-Sen lideram em volume, combinando alta produtividade acadêmica com acesso a grandes populações de pacientes. Implicação: dados regulatórios relevantes serão crescentemente gerados na Ásia — o monitoramento competitivo precisa incluir publicações e agências regulatórias asiáticas.

Cerca de dois terços dos estudos têm patrocínio acadêmico/hospitalar — muitos testando combinações, biossimilares e otimização de regimes já aprovados. A indústria farmacêutica concentra-se nos ativos proprietários de maior valor (ADCs, novas moléculas), tema das seções 5 a 7.

4. Análise por Indicação (subtipo × estágio)

Para uma leitura clínica acionável, segmentamos o pipeline em dois eixos: o subtipo molecular (que define a biologia do tumor e a estratégia de droga) e o estágio da doença (que define o objetivo terapêutico — curativo vs. controle). Como esperado para uma busca centrada em HER2, 677 estudos (93%) são HER2-positivos.

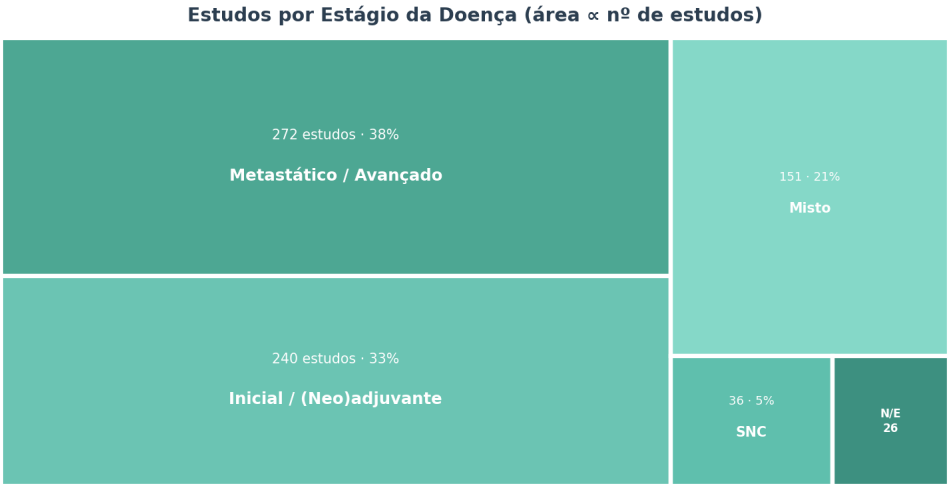


Figura 4 — Mapa de árvore do pipeline por estágio clínico. A doença metastática e a inicial/(neo)adjuvante concentram a grande maioria dos estudos.

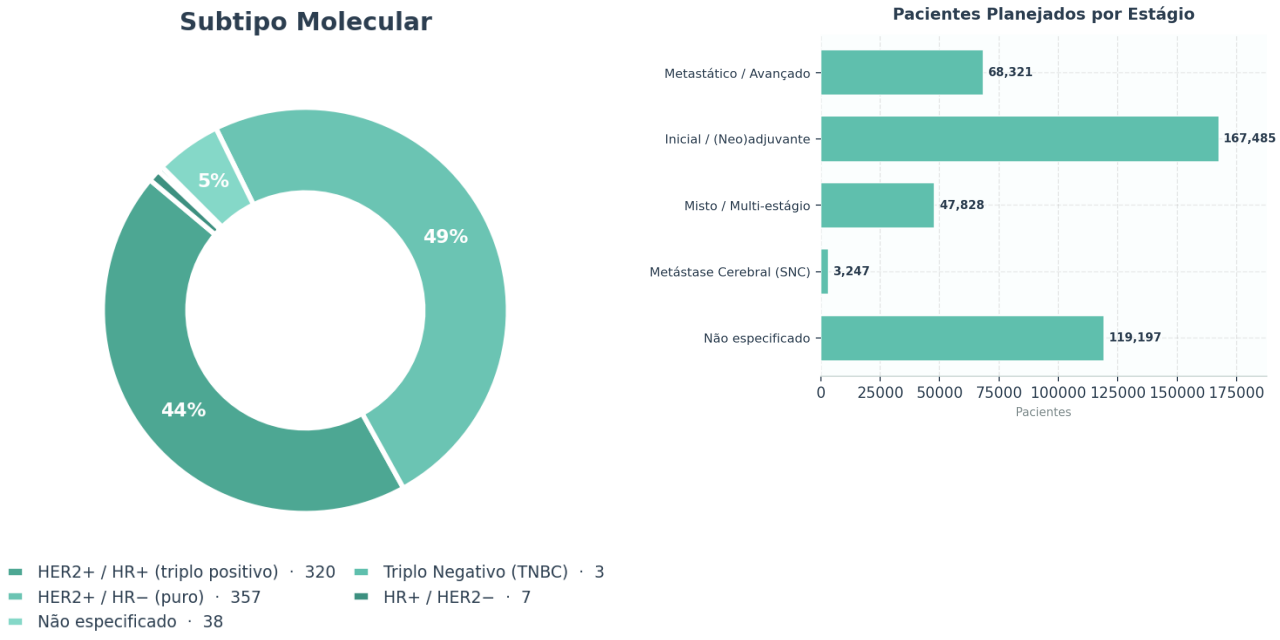


Figura 5 — Subtipo molecular (esq.) e capacidade de pacientes por estágio (dir.). A doença inicial concentra a maior capacidade — estudos adjuvantes são grandes.

Matriz Subtipo × Estágio

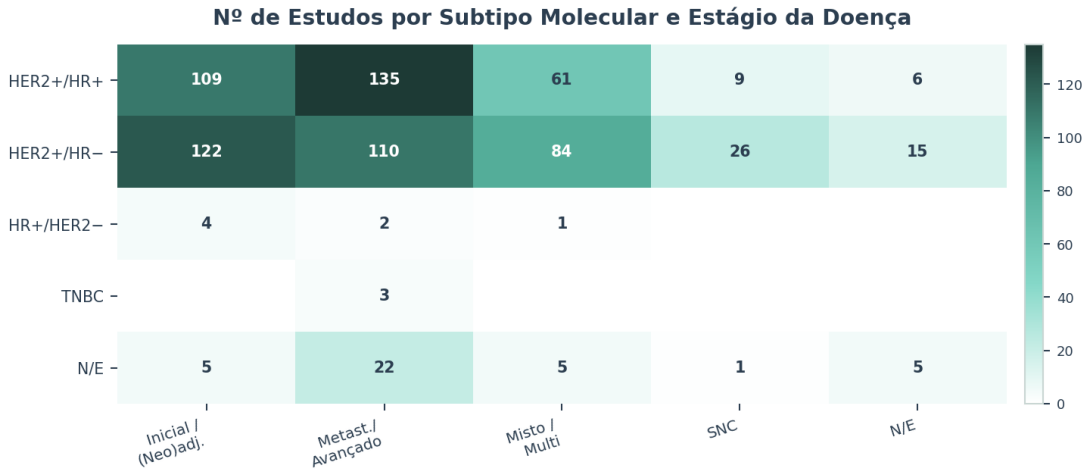


Figura 6 — Cruzamento entre subtipo e estágio. Concentra-se onde a competição é mais intensa: HER2+ (triplo positivo e puro) na doença metastática e inicial.

Resumo Quantitativo por Estágio Clínico

Estágio da doença	Nº Estudos	Pacientes Est.	Fase 3	Recrutando
Metastático / Avançado	272	68,321	79	139
Inicial / (Neo)adjuvante	240	167,485	78	118
Misto / Multi-estágio	151	47,828	45	73
Metástase Cerebral (SNC)	36	3,247	1	21
Não especificado	26	119,197	7	11

Leitura estratégica: a doença metastática é o campo de batalha competitivo mais ativo (maior nº de estudos, ciclos mais rápidos), enquanto a doença inicial/(neo)adjuvante é o território de maior valor de longo prazo (estudos grandes, intenção curativa, desfechos definitivos). A metástase cerebral (SNC), embora pequena em volume, é um unmet need de alto valor onde TKIs como tucatinib e pyrotinib se diferenciam.

5. Paisagem Terapêutica — Fármacos e Classes

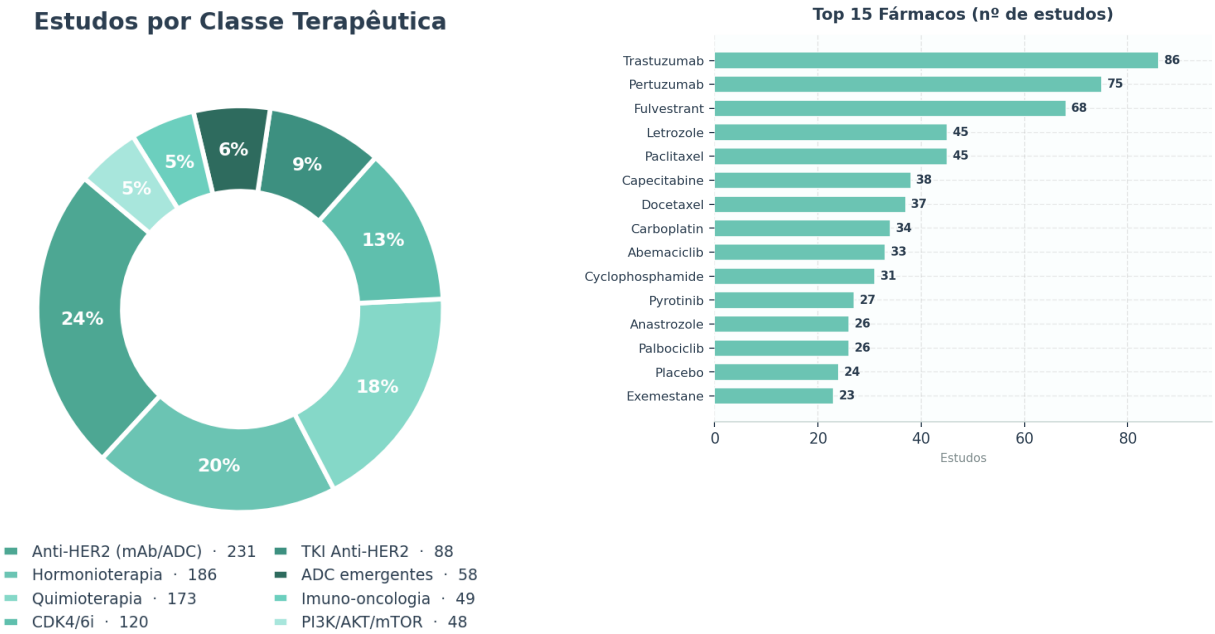


Figura 7 — Classes terapêuticas (esq.) e fármacos mais frequentes (dir.). Trastuzumab e pertuzumab seguem como espinha dorsal; ADCs e CDK4/6i em ascensão.

Análise por Classe Terapêutica

Anti-HER2 (mAb / ADC)	Backbone do tratamento. Trastuzumab e pertuzumab continuam como base, mas os ADCs de nova geração — liderados por T-DXd (AstraZeneca/Daiichi Sankyo) — estão redefinindo o padrão de cuidado na doença metastática e avançando para linhas mais precoces.
TKI Anti-HER2	Inibidores de tirosina quinase (tucatinib, pyrotinib, neratinib) com destaque em metástase cerebral. Pyrotinib domina na China; tucatinib avança no Ocidente.
CDK4/6 Inibidores	Investigados em combinação com anti-HER2 e hormonioterapia, testando se a eficácia em HR+/HER2- se traduz no contexto HER2+/HR+ (triplo positivo).
Imuno-oncologia	Combinações de checkpoint inhibitors com anti-HER2; resultados mistos, com hipótese ativa no subgrupo PD-L1 alto.
ADCs Emergentes	A próxima geração (SHR-A1811, ARX788, RC48) está majoritariamente em desenvolvimento na China — concorrentes diretos de T-DXd, com cargas úteis e perfis de segurança diferenciados.

6. Análise Competitiva — Patrocinadores

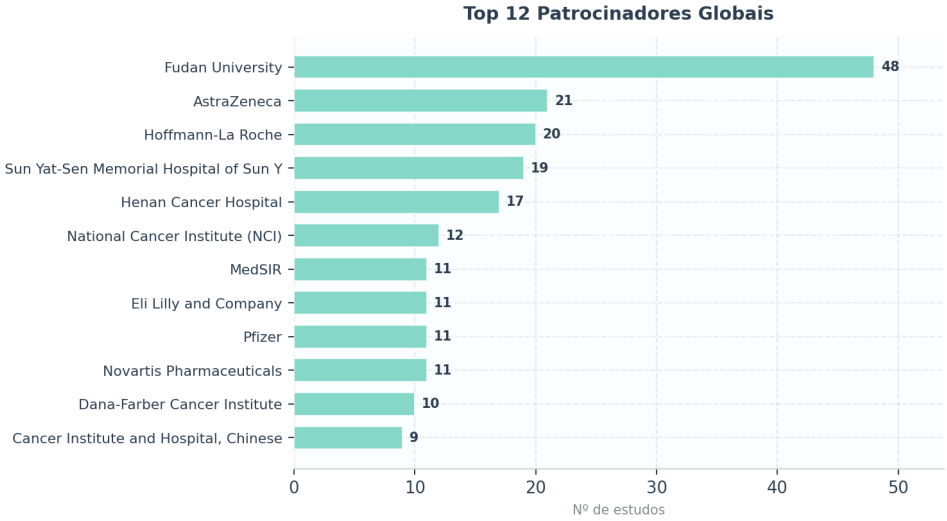


Figura 8 — Ranking de patrocinadores por nº de estudos ativos. Instituições acadêmicas chinesas lideram em volume.

Posicionamento Estratégico — Grandes Farmacêuticas

Empresa	Estudos	Foco Principal	Estágio	Diferencial
AstraZeneca	20	T-DXd (metastático → early)	Fase 3 / Comercial	Líder global em ADCs
Roche	18	Trastuzumab, Pertuzumab, Giredestrant	Fase 3 / Comercial	Fundador do padrão de cuidado
Novartis	12	Alpelisib + anti-HER2, CDK4/6	Fase 2/3	Foco em combinações
Eli Lilly	11	Abemaciclib	Fase 3 / Comercial	Liderança em CDK4/6
Pfizer / Seagen	10	Palbociclib, Tucatinib	Fase 2/3	TKI + CDK4/6
MSD (Merck)	8	Pembrolizumab (IO + anti-HER2)	Fase 2/3	Imuno-oncologia

Dois jogos paralelos: as Big Pharma ocidentais (AstraZeneca, Roche, Novartis, Lilly, Pfizer) competem por ativos proprietários de alto valor — ADCs, TKIs seletivos e combinações com CDK4/6. Em paralelo, o ecossistema acadêmico/farmacêutico chinês gera volume massivo de estudos, incluindo ADCs concorrentes e biossimilares, com impacto regulatório crescente no maior mercado oncológico do mundo.

7. Pipeline Emergente — ADCs e Novas Moléculas

Os Anticorpos Conjugados a Drogas (ADCs) são o segmento de maior dinamismo inovador no pipeline HER2+. A tabela consolida os principais ADCs em investigação clínica ativa na base.

ADCs em Investigação Clínica Ativa

Composto (ADC)	Estudos	Fases	Patrocinador (1º)	Pacientes
Trastuzumab Deruxtecan	50	Fase 1/2, Fase 2	AstraZeneca	14,515
SHR-A1811	30	Fase 1/2, Fase 2	Cancer Institute and Hospi	7,500
Disitamab Vedotin	11	Fase 1/2, Fase 2	Fudan University	1,717
Trastuzumab Emtansine	8	Fase 2, Fase 3	Alliance for Clinical Tria	5,145
ARX788	7	Fase 2, Fase 2/3	Ambrx, Inc.	5,362
Patritumab Deruxtecan	6	Fase 1/2, Fase 2	Daiichi Sankyo	1,941
Datopotamab Deruxtecan	4	Fase 2, Fase 3	AstraZeneca	2,792
DP303c	2	Fase 3	CSPC ZhongQi Pharmaceutica	862
A166	2	Fase 2, Fase 3	Sichuan Kelun-Biotech Biop	405
Trastuzumab-Emtansine	1	Fase 2	Dana-Farber Cancer Institu	500

Outras Terapias Emergentes de Destaque

Molécula	Classe	Empresa	Estágio	Descrição
Trastuzumab Deruxtecan	ADC HER2 (DXd)	AstraZeneca / Daiichi	Comercial / Fase 3	Redefine o padrão em metastático; expandindo para HER2-low e early
SHR-A1811	ADC HER2	Jiangsu Hengrui	Fase 2/3	Principal concorrente asiático de T-DXd; dados promissores
Zanidatamab	Bispecífico HER2	Zymeworks / Jazz	Fase 2/3	Anticorpo bispecífico com mecanismo duplo de ligação
Tucatinib	TKI HER2-seletivo	Seagen (Pfizer)	Fase 2/3	Alta seletividade; eficaz em metástase cerebral
Pyrotinib	TKI pan-HER	Hengrui	Fase 2/3	Dominante na China; dados maduros de Fase 3
Margetuximab	Anti-HER2 (Fc-otimizado)	MacroGenics	Fase 3	Engenharia de Fc para maior atividade imune; aprovado FDA

Tese de inovação: a competição em HER2+ está se deslocando de "qual anti-HER2" para "qual ADC" — e, dentro dos ADCs, para a diferenciação por carga útil, taxa droga:anticorpo (DAR) e perfil de segurança. A entrada de candidatos asiáticos pressiona preço e acelera o ciclo de inovação global.

8. Presença no Brasil

Nota metodológica: a coleta não preservou o módulo de localizações (centros por país) para reduzir o tamanho do banco. A identificação de estudos com o Brasil foi feita por busca textual no JSON — portanto é conservadora e possivelmente subestimada. Recomenda-se recoleta com o módulo contactsLocationsModule e cruzamento com o REBEC para o quadro geográfico completo.

Foram identificados 6 estudos com menção ao Brasil:

NCT03155997 Fase 3	Endocrine Therapy With or Without Abemaciclib (LY2835219) Following Surgery in Participants With Breast Cancer Status: Ativo / Não Recrutando · Pacientes: 5,637 · Patrocinador: Eli Lilly and Company Estudo com menção textual ao Brasil no JSON da ClinicalTrials.gov (proxy conservador; sem módulo de localizações).
NCT06757634 Fase 3	Phase 3 Study of Gedatolisib as First-Line Treatment for Patients With HR-Positive, HER2-Negative Advanced Breast Cancer (VIKTORIA-2) Status: Recrutando · Pacientes: 1,180 · Patrocinador: Celcuity Inc Estudo com menção textual ao Brasil no JSON da ClinicalTrials.gov (proxy conservador; sem módulo de localizações).
NCT05113251 Fase 3	Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) Alone or in Sequence With THP, Versus Standard Treatment (ddAC-THP), in HER2-positive Early Breast Cancer Status: Ativo / Não Recrutando · Pacientes: 927 · Patrocinador: AstraZeneca Estudo com menção textual ao Brasil no JSON da ClinicalTrials.gov (proxy conservador; sem módulo de localizações).
NCT02763566 Fase 3	A Study of Abemaciclib (LY2835219) in Participants With Breast Cancer Status: Ativo / Não Recrutando · Pacientes: 463 · Patrocinador: Eli Lilly and Company Estudo com menção textual ao Brasil no JSON da ClinicalTrials.gov (proxy conservador; sem módulo de localizações).
NCT04208178 Fase 3	Study of Alpelisib (BYL719) in Combination With Trastuzumab and Pertuzumab as Maintenance Therapy in Patients With HER2-positive Advanced Breast Cancer With a PIK3CA Mutation Status: Ativo / Não Recrutando · Pacientes: 19 · Patrocinador: Novartis Pharmaceuticals Estudo com menção textual ao Brasil no JSON da ClinicalTrials.gov (proxy conservador; sem módulo de localizações).
NCT04576455 Fase 2	A Study Evaluating the Efficacy and Safety of Giredestrant Compared With Physician's Choice of Endocrine Monotherapy in Participants With Previously Treated Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer (acelERA Breast Cancer) Status: Ativo / Não Recrutando · Pacientes: 303 · Patrocinador: Hoffmann-La Roche Estudo com menção textual ao Brasil no JSON da ClinicalTrials.gov (proxy conservador; sem módulo de localizações).

Oportunidade Estratégica para o Brasil

O Brasil é uma oportunidade significativamente subutilizada no pipeline HER2+. Com apenas 6 estudos em 725 (< 1%), a presença nacional está muito aquém do potencial do país — população expressiva, alta incidência e infraestrutura oncológica de referência (INCA, A.C. Camargo, Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCor, entre outros). Recomendação: mapeamento proativo via REBEC, articulação com patrocinadores globais para inclusão de centros brasileiros em estudos Fase 2/3 ainda em site selection, e posicionamento do país como hub regional de pesquisa.

9. Análise Regulatória e Ciclo de Vida do Pipeline

Esta seção avalia a maturidade do pipeline — estudos Fase 3 (pré-registro) com maior potencial de impacto regulatório — e o horizonte de geração de dados dos estudos em recrutamento.

Top 7 Estudos Fase 3/2-3 por Capacidade de Pacientes

NCT ID	Título (resumido)	Patrocinador	Fármacos	Pacientes	Início
NCT03233191	Digital Tomosynthesis Mammography and Digital Ma...	ECOG-ACRIN Cancer Rese		108,508	2017-09
NCT00310180	Hormone Therapy With or Without Combination Chem...	National Cancer Instit	Anastrozole, Exemestane...	10,273	2006-04
NCT05514054	A Study of Imlunestrant Versus Standard Endocrin...	Eli Lilly and Company	Imlunestrant, Tamoxifen...	8,000	2022-10
NCT02513394	PALbociclib CoLlaborative Adjuvant Study	Alliance Foundation Tr	Palbociclib, Standard Adju	5,796	2015-08
NCT03155997	Endocrine Therapy With or Without Abemaciclib (L...	Eli Lilly and Company	Abemaciclib, Standard Adju	5,637	2017-07
NCT03701334	A Trial to Evaluate Efficacy and Safety of Riboc...	Novartis Pharmaceutica	Ribociclib	5,101	2018-12
NCT01272037	Tamoxifen Citrate, Letrozole, Anastrozole, or Ex...	National Cancer Instit	Anastrozole, Exemestane...	5,018	2011-02

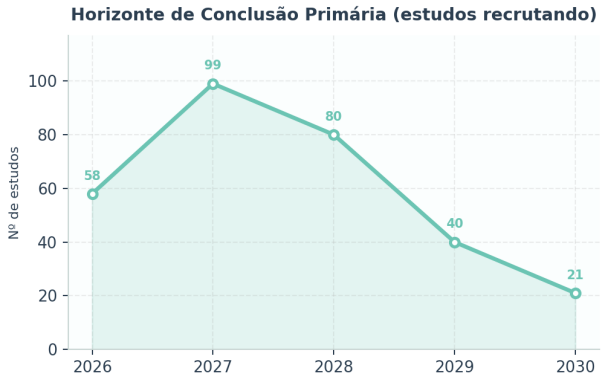


Figura 9 — Horizonte de leitura de dados para estudos em recrutamento: o pico de 2026–2027 antecipa uma onda relevante de resultados.

Indicador de Maturidade por Estágio

Estágio	% em Fase 3/2-3	% Recrutando	Mediana de Pacientes
Metastático / Avançado	29.0%	51.1%	152
Inicial / (Neo)adjuvante	32.5%	49.2%	167
Misto / Multi-estágio	29.8%	48.3%	150
Metástase Cerebral (SNC)	2.8%	58.3%	51
Não especificado	26.9%	42.3%	70

Síntese regulatória: com 210 estudos em Fase 3/2-3 e um pico de leituras previsto para 2026–2027, os próximos 24 meses devem trazer múltiplos marcos capazes de redefinir o padrão de cuidado — especialmente na doença metastática e na expansão de ADCs para linhas mais precoces.

10. Conclusões e Recomendações Estratégicas

Com base na análise de 725 ensaios clínicos ativos em câncer de mama HER2+, destacamos as recomendações prioritárias para a tomada de decisão executiva:

1	Monitorar a corrida dos ADCs T-DXd já redefine o padrão em metastático e avança para linhas precoces; SHR-A1811, ARX788 e RC48 formam a próxima onda (sobretudo asiática). Ação: alertas regulatórios e de publicação dedicados a estes compostos, incluindo agências da China, Japão e Coreia.
2	Capturar valor nas combinações CDK4/6 + anti-HER2 Dezenas de estudos testam essa combinação no subgrupo triplo positivo. Ação: acompanhar leituras de 2026–2027 (ver Figura 9) para antecipar reposicionamento de portfólio.
3	Ativar centros brasileiros Presença < 1% do pipeline global representa oportunidade competitiva clara. Ação: mapear centros tier-1 nacionais e abrir diálogo com patrocinadores globais em fase de seleção de sites.
4	Construir inteligência sobre metástase cerebral (SNC) Volume baixo, mas unmet need alto, onde TKIs (tucatinib, pyrotinib) se diferenciam. Ação: avaliar protocolo nacional específico e parcerias acadêmicas.
5	Estabelecer vigilância competitiva sobre a China O eixo de P&D; migrou para a Ásia (≥36% dos estudos). Ação: incluir periódicos e registros regulatórios chineses no monitoramento contínuo de literatura e pipeline.

Próximos Passos Recomendados

→ Recoleta dos dados preservando o módulo de localizações para análise geográfica completa

→ Cruzamento com o REBEC para identificar estudos registrados no Brasil

→ Monitoramento trimestral de novos registros nas indicações e moléculas prioritárias

→ Análise de endpoints dos estudos Fase 3 para antecipar marcos regulatórios (2026–2027)

→ Mapeamento de KOLs associados aos estudos de maior impacto, com foco em Ásia e Brasil

Fontes: ClinicalTrials.gov (U.S. National Library of Medicine). Coleta: 16/10/2026. Análise: Pesquisa e Dados. Metodologia: API v2; filtros Fase 2/3/4, tipo Interventional, status ativo/recrutando; classificação clínica por processamento textual. Relatório de uso interno exclusivo e confidencial — gerado em Outubro de 2026.